Compétences psychosociales (CPS)

CPS · agir dans la vie réelle

Selon l'OMS, capacités à faire face aux exigences et épreuves de la vie, à adopter une conduite adaptée et à préserver son bien-être dans ses relations et son environnement.

Savoirs = connaître ; savoir-faire = réaliser ; CPS = mobiliser des capacités personnelles, émotionnelles et sociales. Les trois se complètent.

Cognitives · analyser et choisir

Résoudre les problèmes ; prendre des décisions ; penser de façon créative ; exercer une pensée critique.

Question utile : « Comment j'analyse la situation et quelles options ai-je ? »

Émotionnelles · se réguler

Conscience de soi ; empathie ; gestion du stress ; gestion des émotions.

Repérer ce que l'on ressent et ce que ressent autrui, puis choisir une réponse adaptée.

Développer les CPS dans les soins

Sociales · interagir

Communication efficace ; relations interpersonnelles ; affirmation de soi, négociation et résistance à la pression.

Exemple : savoir dire non à une pression familiale ou du groupe.

Pourquoi les développer ?

Bandura : sentiment d'auto-efficacité = croire que l'on peut réussir une action. Valoriser les petites réussites aide à agir.

Résilience : capacité à se développer malgré l'adversité ; les ressources du milieu comptent. Le contexte familial, social et de soins influe sur les CPS.

Auprès du patient et chez le soignant

Éducation thérapeutique : au-delà de l'information, entraîner une compétence concrète. Patient diabétique sous pression : pratiquer des réponses pour refuser.

IDE : gérer le stress, communiquer en équipe, exprimer une difficulté et demander du soutien. Les CPS s'apprennent et se renforcent.